



Diário Clínico

Consulta Externa

10-Set-2025 Dr(a). Ana Margarida Faria (HUC-REUMATOLOGIA)

58A, AR seropositiva dx 2021, sob MTX 15 mg/sem + AF 5 mg/sem, prednisolona 5 mg id. Com HTA, hipotireoidismo, DLP, epilepsia focal controlada e anemia ferropénica crónica. Sem crises epiléticas há cerca de 2 anos. Mantém perindopril/indapamida, levotiroxina, rosuvastatina, omeprazol, Fe oral e colecalciferol. Refere adesão global à terapêutica, sem esquecimentos relevantes de MTX; toma AF em dia distinto. Sem intolerância digestiva, úlceras orais, infeções recorrentes, dispneia ou tosse persistente. Sem febre, emagrecimento ou sudorese nocturna.

Queixa-se de persistência de rigidez matinal mãos/punhos, habitualmente 45-60 min, com melhoria parcial após mobilização. Dor mecânica-inflamatória sobretudo MCF 2.^a-3.^a bilateral e punhos, mais incómoda nas últimas semanas; nega dor nocturna incapacitante. Tumefacção ligeira intermitente, sem rubor marcado. Dificuldade em abrir frascos, rodar chaves e tarefas finas de manhã; mantém autonomia nas AVD. Sem queixas relevantes em ombros, cotovelos, joelhos, tornozelos ou MTF. Sem nódulos reumatóides conhecidos. Xerostomia habitual, sem agravamento; ingesta frequente de água, sem disfagia, candidíase oral ou aumento de parótidas. Sem xeroftalmia exuberante. Mantém cefaleias tensionais esporádicas, sem alteração do padrão. Sem intercorrências infecciosas desde IU baixa tratada em 08/2025, entretanto resolvida.

EO: bom estado geral, consciente, colaborante. TA 132/78 mmHg, FC 74 bpm regular, SpO2 98% AA, T 36,4°C. Sem adenopatias periféricas. Mucosa oral discretamente seca, sem aftose, sem placas esbranquiçadas. Mãos sem deformidades fixas, sem desvio cubital, sem dedo em pescoço de cisne/botoeira; discreta tumefacção e dor à palpação MCF 2.^a D, MCF 3.^a D, MCF 2.^a E e punho D, com sinovite palpável em MCF 2.^a-3.^a D e punho D, suspeita discreta em MCF 2.^a E. Punho E doloroso na mobilização terminal, sem derrame franco. ADM global preservada, força de preensão discretamente diminuída bilateralmente por dor. IFP/IFD sem sinovite. Cotovelos, ombros, joelhos, tornozelos e MTF sem tumefacção ou limitação inflamatória objetiva. Sem rash, livedo ou vasculite periférica.

MCDTs 10/09/2025: Hb 11,7 g/dL, Ht 35,8%, VGM 82 fL, HGM 26,8 pg, RDW 15,1%, leucócitos $7,4 \times 10^9/L$ com neutrófilos $4,6 \times 10^9/L$, linfócitos $2,0 \times 10^9/L$, plaquetas $342 \times 10^9/L$. Sem leucopenia, neutropenia ou trombocitopenia sob MTX. VS 38 mm/1.^a hora, PCR 14,6 mg/L, compatíveis com atividade inflamatória ligeira-moderada. Creatinina 0,78 mg/dL, TFG_e 88 mL/min/1,73m², ureia 31 mg/dL, ionograma com Na 139 mmol/L, K 4,2 mmol/L, sem compromisso renal limitante de terapêutica. AST 21 U/L, ALT 24 U/L, GGT 28 U/L, FA 86 U/L, bilirrubina total 0,4 mg/dL, albumina 4,1 g/dL; sem citólise ou colestase. Ferritina 24 ng/mL, ferro sérico 48 µg/dL, saturação transferrina 14%, mantendo ferropenia ligeira sem agravamento da anemia. TSH 2,16 mUI/L, FT4 1,18 ng/dL, eutiroidia sob levotiroxina.

Rx mãos e punhos bilateral, AP/oblíquas, realizada para reavaliação estrutural. Discreta osteopenia justa-articular periarticular mais evidente nas MCF e carpos. Estreitamento muito ligeiro dos espaços articulares radiocárpicos bilateralmente, sem colapso carpiano. Pequenas irregularidades corticais marginais na cabeça do 2.^o metacárpico direito e base da falange proximal correspondente, sem erosões francas novas ou progressivas. Sem subluxações MCF, sem desvio



Diário Clínico

Consulta Externa

ulnar e sem deformidades estruturais estabelecidas. Comparativamente ao estudo de 2023, sem progressão radiográfica significativa; quadro de artrite inflamatória de baixa expressão erosiva.

DAS28-CRP estimado 3,6, atividade moderada, com sinovite residual periférica e elevação persistente de reagentes de fase aguda. Sem toxicidade hematológica, renal ou hepática atribuível a MTX. Mantém-se prednisolona 5 mg id e MTX 15 mg/sem com AF 5 mg/sem em dia não coincidente, sem alteração imediata por agora. Discutida necessidade provável de otimização de DMARD se persistência de atividade clínica/analítica; ponderar escalada de MTX para 20 mg/sem ou terapêutica combinada após reavaliação, tendo em conta tolerância e perfil infeccioso. Manter vigilância de xerostomia, medidas locais, hidratação e higiene oral. Repetir hemograma, VS, PCR, creatinina, AST/ALT/GGT antes da próxima consulta. Reavaliação em 8-10 semanas; antecipar se agravamento de tumefacção, rigidez prolongada, febre ou infeção.

24-Set-2025 Dr(a). Ricardo Vale (HUC-NEUROLOGIA)

58A, seguimento por epilepsia focal. AP relevantes: AR sob terapêutica imunomoduladora, HTA, hipotireoidismo, DLP, anemia ferropénica crónica. Sem intercorrências neurológicas desde última observação, há cerca de 6 meses. Nega crises focais sensitivas/motoras, episódios de desconexão, automatismos, fenómenos autonómicos ou generalização bilateral tónico-clónica. Sem quedas, traumatismos, idas à Urgência ou necessidade de medicação de resgate. Mantém autonomia completa nas AVD e actividade habitual.

Boa adesão a levetiracetam 500 mg 2id; nega omissões. Sem sonolência excessiva, tontura persistente, instabilidade, irritabilidade, labilidade afectiva ou outras queixas atribuíveis ao FAE. Sono globalmente preservado. Sem consumo etílico excessivo. Sem privação de sono relevante.

Refere cefaleias ocasionais, de predomínio holocraniano/occipital, tipo aperto, intensidade ligeira a moderada, habitualmente em períodos de maior stress, sem agravamento progressivo. Sem náusea/vómito, foto/fonofobia marcada, despertar nocturno por cefaleia, alteração visual, diplopia, défice focal, alteração cognitiva ou associação temporal a crises. Melhoria com repouso e analgésico simples pontual. Clínica compatível com cefaleia tipo tensão; sem sinais de alarme actuais.

EO: TA 132/78 mmHg, FC 72 bpm regular, SatO2 98% ar ambiente, T 36,4°C. Vigil, colaborante, orientada auto/alo e temporalmente; linguagem fluente, compreensão e nomeação preservadas. Pares cranianos sem alterações; pupilas isocóricas e fotorreactivas, motilidade ocular extrínseca completa, sem nistagmo, face simétrica. Força 5/5 nos quatro membros, tónus conservado, sem drift pronador. ROT presentes, vivos mas simétricos, cutâneo-plantar flexor bilateral. Sensibilidade superficial sem assimetrias evidentes. Coordenação dedo-nariz e calcanhar Joelho sem dismetria. Marcha autónoma, base e balanço normais; tandem efectuado sem dificuldade. Sem sinais meníngeos.

Sem EEG ou neuroimagem recentes para reavaliação; face a estabilidade clínica prolongada e EO sem focalidade, sem indicação actual para antecipar estudo imagiológico. Manter levetiracetam 500 mg 2id, sem alterações. Reforçadas adesão terapêutica, higiene do sono e evicção de factores



Diário Clínico

Consulta Externa

precipitantes. Orientada para contacto precoce se recorrência de eventos paroxísticos, alteração do padrão das cefaleias ou surgimento de sinais focais. Consulta de seguimento em 6 meses.

15-Out-2025 Dr(a). Rui Valente (HUC-MEDICINA_INTERNA)

58A, reavaliação global HTA, DLP e anemia ferropénica crónica. AP: HTA, DLP, hipotiroidismo sob substituição, AR de actividade moderada sob MTX/corticoterapia crónica, epilepsia focal controlada; osteopenia associada a corticoterapia. Sem crises epilépticas há >2 anos. Sem intercorrências cardiovasculares desde última observação. Boa adesão terapêutica, sem efeitos adversos relevantes referidos.

Sem dor torácica, dispneia de esforço nova, ortopneia, DPN, palpitações sustentadas, síncope ou claudicação. Nega cefaleia persistente, défices focais ou alterações visuais. Tontura postural ocasional, breve, sem queda/síncope; sem agravamento recente. Sem edemas, ganho ponderal súbito ou redução da diurese. Mantém restrição salina parcial; actividade física ainda escassa por queixas osteoarticulares, mas marcha diária curta. Sem tabagismo. Queixas dispépticas esporádicas, sem vômitos, melena, rectorragias ou alteração do trânsito intestinal.

Refere infecção urinária baixa em 08/2025, resolvida após ATB oral; actualmente sem disúria, polaquiúria, urgência, febre, dor lombar ou hematuria. Sem novas infecções. Mantém sulfato ferroso diariamente, tolerado, sem obstipação significativa. Sem astenia limitante, lipotímias, dispneia desproporcionada ou sinais de perda hemática exteriorizada.

MH: perindopril 5 mg id, indapamida LP 1,5 mg id, rosuvastatina 10 mg id, sulfato ferroso 80 mg id; mantém ainda levotiroxina 75 mcg id, MTX 15 mg/semana + AF 5 mg/semana, prednisolona 5 mg id, levetiracetam 500 mg 2id, omeprazol 20 mg id e colecalciferol 25.000 UI/mês. Sem alterações recentes. Alergia a penicilina (exantema); reacção broncospástica ligeira prévia a contraste iodado.

EO: bom estado geral, consciente, colaborante, eupneica em ar ambiente. TA 128/74 mmHg, FC 72 bpm regular, SpO2 98%, T 36,4°C, peso 68,2 kg, IMC 26,1 kg/m². AC rítmica, tons normofonéticos, sem sopros. AP sem ruídos adventícios. Sem turgência jugular, sem edemas maleolares; pulsos periféricos palpáveis e simétricos. Abdómen flácido, indolor, sem massas ou organomegalias palpáveis.

Analítica de 09/10/2025: Hb 11,6 g/dL, Htc 35,8%, eritrócitos 4,12 x10⁶/uL, VGM 86,9 fL, HGM 28,2 pg, CHGM 32,4 g/dL, RDW 15,1%, leucócitos 6,8 x10³/uL, neutrófilos 4,2 x10³/uL, plaquetas 286 x10³/uL. Reticulócitos 1,3%. Ferro 54 µg/dL, ferritina 24 ng/mL, transferrina 286 mg/dL, saturação transferrina 13%. Hb em recuperação face a 10,9 g/dL em 06/2025, persistindo anemia ligeira, normocítica, com reservas de ferro ainda baixas.



Diário Clínico

Consulta Externa

PCR 7,8 mg/L, VS 31 mm/h, compatível com contexto inflamatório crónico por AR, sem subida significativa face a controlos prévios.

Creatinina 0,78 mg/dL, TFG_e 88 mL/min/1,73m², ureia 31 mg/dL, Na 139 mmol/L, K 4,2 mmol/L, Ca 9,3 mg/dL. AST 19 U/L, ALT 21 U/L, GGT 24 U/L, FA 82 U/L, bilirrubina total 0,4 mg/dL, albumina 4,1 g/dL. Glicemia em jejum 91 mg/dL, HbA1c 5,6%. TSH 2,14 mUI/L, T4L 1,18 ng/dL. Urina II sem proteinúria, glicose, nitritos ou leucocitúria; sedimento sem hematúria. Relação albumina/creatinina urinária 8 mg/g.

Perfil lipídico de 09/10/2025: colesterol total 174 mg/dL, LDL-c 91 mg/dL, HDL-c 58 mg/dL, triglicéridos 124 mg/dL, não-HDL 116 mg/dL. Melhoria progressiva comparativamente a 03/2025, então CT 198 mg/dL, LDL-c 112 mg/dL e TG 156 mg/dL. Mantém boa resposta à rosuvastatina, sem mialgias, elevação de transaminases ou CK 96 U/L. Risco CV global condicionado por HTA, dislipidemia e doença inflamatória crónica; objectivo LDL preferencialmente <100 mg/dL, actualmente atingido.

Revista ecografia reno-vesical de 11/2024. Rins de dimensões e diferenciação corticomedular preservadas, sem litíase, ectasia pielocalicial ou massas sólidas. No pólo inferior do rim esquerdo identifica-se imagem anecogénica cortical, ovalada, de paredes finas, 15 x 13 mm, sem septos, componente sólido ou vascularização ao Doppler, compatível com quisto simples Bosniak I. Bexiga com adequada repleção, parede regular, sem imagens endoluminais; resíduo pós-miccional não significativo. Sem alterações relevantes face a ecografia abdominal anterior. Pelo aspecto inequívoco de quisto renal simples e ausência de sintomatologia urinária actual, sem indicação para vigilância imagiológica dirigida.

HTA controlada sob dupla terapêutica, função renal e ionograma estáveis. DLP em melhoria, LDL em alvo. Anemia ferropénica crónica em recuperação parcial, sem evidência clínica/analítica actual de hemorragia ou deterioração renal. Mantém esquema terapêutico sem alterações. Reforçadas dieta hipossalina, padrão alimentar mediterrânico, redução de gorduras saturadas/açúcares simples, exercício aeróbio regular adaptado à tolerância articular e controlo ponderal. Manter ferro oral; vigilância de Hb, ferritina, saturação transferrina, função renal, ionograma, perfil lipídico e função hepática em 4-6 meses. Orientada para recorrer se sintomas urinários, hematúria, intolerância ao esforço progressiva, lipotímia, dor torácica ou dispneia.

20-Jan-2026 Dr(a). Rui Manuel Tavares (HUC-GASTRENTEROLOGIA)

1.^a obs. pós-SU 03/12/25, por pirose/regurgitação, EDA então compatível com hérnia hiatal e esofagite. AP: AR sob MTX/corticoterapia crónica, anemia ferropénica, HTA, hipotireoidismo, DLP, epilepsia focal controlada. Refere melhoria marcada desde pantoprazol 40 mg id: pirose agora ocasional, sobretudo após refeições volumosas/tardias;

Processado por computador - SClinico



Diário Clínico

Consulta Externa

regurgitação ácida rara, sem despertar nocturno. Nega disfagia, odinofagia, impactação alimentar, vômitos, hematemese, melenas, dor epigástrica persistente, anorexia ou perda ponderal. Trânsito intestinal habitual. Queixas dispépticas esporádicas prévias, pós-prandiais, sem relação temporal evidente com MTX ou restantes fármacos, sem agravamento recente.

MH relevante: pantoprazol 40 mg id; omeprazol previamente 20 mg id, suspender — não manter dupla IBP. Prednisolona 5 mg id, MTX 15 mg/semana, ácido fólico. Evita AINEs. Sem etilismo significativo, não fumadora.

EO: bom estado geral, eupneica. TA 132/76 mmHg, FC 72 bpm, SpO2 98% ar ambiente, T 36,4°C. Abdómen plano, depressível, indolor à palpação superficial/profunda; sem massas, sem visceromegalias, sem sinais de irritação peritoneal.

MCDTs: EDA de 03/12/25, realizada em contexto de urgência, com progressão fácil até D2. Esófago com mucosa distal eritematosa, friável, apresentando erosões lineares milimétricas nos últimos ~3 cm, sem úlcera profunda, sem estenose e sem lesões suspeitas; achados compatíveis com esofagite erosiva ligeira, LA A/B. Junção esofagogástrica acima do pinçamento diafragmático, com hérnia hiatal por deslizamento estimada em cerca de 3 cm. Estômago com distensibilidade conservada, sem conteúdo hemático ou estase, mucosa antral sem erosões relevantes; piloro permeável. Bolbo e D2 sem alterações macroscópicas. Sem sinais endoscópicos de Barrett; não efectuadas biópsias. Analítica de 06/12/25: Hb 11,4 g/dL, VGM 82 fL, leucócitos $6,8 \times 10^9/L$, plaquetas $312 \times 10^9/L$, ferritina 18 ng/mL, PCR 6 mg/L, AST 22 U/L, ALT 19 U/L, creatinina 0,78 mg/dL.

Mantém pantoprazol 40 mg id, 30 min antes do pequeno-almoço; se assintomática durante 8 sem, ponderar redução para 20-40 mg id. Reforçadas medidas anti-refluxo: refeições pequenas/fraccionadas, evitar deitar nas 3 h pós-prandiais, elevação cabeceira, redução de gorduras/café/chocolate conforme tolerância, controlo ponderal. Vigilância de disfagia, hemorragia digestiva, vômitos persistentes ou emagrecimento. Programar EDA de reavaliação em 6-12 meses, idealmente sob terapêutica optimizada; antecipar se recorrência sintomática ou sinais de alarme.

17-Fev-2026 Dr(a). Rui Mendonça (HUC-ORTOPEDIA)

58A, lombalgia mecânica recorrente, flutuante, predomínio lombo-sagrado, sem irradiação ciática atual. Episódio agudo 03/2025 resolvido; desde então crises breves após esforços/flexão mantida, melhoria com repouso relativo. Nega dor noturna persistente, febre, perda ponderal, trauma recente, alterações esfíncterianas ou défice motor/sensitivo. Sem quedas ou fracturas de baixo impacto conhecidas.



Diário Clínico

Consulta Externa

AP: AR sob corticoterapia crónica, HTA, hipotireoidismo, DLP, anemia ferropénica; osteopenia prévia. MH relevante: prednisolona 5 mg id há vários anos, MTX 15 mg/semana + AF, colecalciferol 25.000 UI/mês; pantoprazol por hérnia hiatal/esofagite.

EO: TA 132/76 mmHg, FC 74 bpm, SpO2 98% AA, T 36,4°C. Marcha autónoma, sem claudicação. Coluna lombar sem desalinhamento evidente, discreta dor à palpação paravertebral baixa bilateral, sem dor à percussão apófises espinhosas. Flexão lombar limitada pelo desconforto terminal; extensão e inclinações preservadas. Lasègue e Bragard negativos bilateralmente. Força 5/5 MI, ROT simétricos, sensibilidade conservada, sem défice radicular. Ancas com mobilidade indolor.

Densitometria óssea 10/02/2026, realizada em coluna lombar L1-L4 e fémur proximal bilateral, comparada com estudo anterior. Coluna lombar com DMO 0,742 g/cm², T-score -2,7 e Z-score -1,6; redução de 6,8% face ao exame prévio, ultrapassando limiar de variação significativa do método. L1 e L2 com valores mais baixos, sem exclusão de vértebras por alterações degenerativas relevantes. Colo do fémur esquerdo DMO 0,655 g/cm², T-score -1,8; fémur total esquerdo 0,781 g/cm², T-score -1,3, globalmente estáveis. Colo do fémur direito DMO 0,662 g/cm², T-score -1,7. Sem discrepância significativa entre anca direita/esquerda. Perfil densitométrico compatível com osteoporose por critério OMS na coluna lombar, em contexto de corticoterapia crónica e AR; risco fracturário aumentado, apesar de ausência de fractura de fragilidade documentada.

Analítica recente: Ca 9,3 mg/dL, P 3,4 mg/dL, FA 82 U/L, creatinina 0,78 mg/dL, eTFG 87 mL/min/1,73m², 25-OH vitamina D 31 ng/mL, PTH 48 pg/mL, TSH 1,62 mUI/L. Sem evidência analítica de causa secundária adicional.

Explicada progressão osteopenia/osteoporose, influência da corticoterapia e necessidade de prevenção de fractura vertebral/anca. Pela esofagite/hérnia hiatal, evitar bisfosfonato oral. Proposta terapêutica com ácido zoledrónico 5 mg EV anual, após avaliação dentária e confirmação de Ca/vitamina D adequados; doente esclarecida, concorda. Manter colecalciferol; assegurar aporte cálcico alimentar ~1000-1200 mg/dia. Reforçadas medidas antiqueda, exercício regular com carga/fortalecimento paravertebral, higiene postural e evitar cargas em flexão. Reavaliar em consulta 3-4 meses, antes após infusão; nova DMO em 24 meses.

10-Mar-2026 Dr(a). Inês Valente (HUC-REUMATOLOGIA)

AR seropositiva, sob MTX, globalmente com ligeira melhoria clínica vs última obs. AP: HTA, hipotireoidismo, DLP, epilepsia focal sem crises há cerca de 2 anos, anemia ferropénica crónica, hérnia hiatal c/ esofagite ligeira, osteoporose recente em contexto de corticoterapia prolongada. Xerostomia ligeira, sem agravamento. Sem infeções



Diário Clínico

Consulta Externa

intercorrentes, febre, perda ponderal, dispneia ou dor torácica. Mantém queixas dispépticas ocasionais, sem odinofagia/disfagia; sob Pantoprazol.

Refere rigidez matinal das mãos ~20-30 min, anteriormente >1h. Dor mecânico-inflamatória residual sobretudo IFP/MCF bilateral, sem tumefação mantida relevante; episódica, condiciona tarefas finas apenas nos dias de maior sobrecarga. Sem dor cervical, ombros, cotovelos, joelhos ou tornozelos de novo. Sem necessidade de AINE regular. Sem efeitos adversos atribuíveis a MTX: nega náuseas persistentes, aftose, alopecia significativa, tosse seca ou infeções recorrentes.

Parestesias transitórias mão D, sobretudo após dormir sobre MS ou flexão mantida do punho, duração minutos, resolução espontânea com mudança postural. Sem dor radicular cervical, défice de força, queda de objectos ou hipoestesia persistente. Sem indicação actual para estudo neurofisiológico; vigilância clínica.

MH: MTX 15 mg/semana, AF 5 mg/semana, prednisolona 5 mg id, omeprazol 20 mg id; alendronato 70 mg/semana e colecalciferol 25.000 UI/mês. Mantém ainda levetiracetam, perindopril/indapamida, levotiroxina, rosuvastatina, sulfato ferroso e pantoprazol. Boa adesão referida. Explicada necessidade de toma correcta de alendronato, jejum, água abundante e manutenção de ortostatismo 30 min; sem agravamento de pirose desde início.

EO: TA 132/76 mmHg, FC 72 bpm regular, SpO2 98% ar ambiente, T 36,4°C. Bom estado geral, sem adenopatias periféricas. Mãos sem sinovite franca MCF/IFP; discreta dor à pressão MCF 2.ª-3.ª bilateral, sem calor local. Pinça e preensão conservadas. Punhos com mobilidade mantida, sem derrame; Tinel/Phalen negativos bilateralmente. Ombros e cotovelos sem limitação. Joelhos sem derrame. Sem edema periférico. Fácies discretamente cushingoide, sem outras alterações cutâneas relevantes.

Analítica 06/03/2026: Hb 11,7 g/dL, Ht 35,8%, VGM 82 fL, HGM 26,8 pg, leucócitos $6,4 \times 10^9/L$, neutrófilos $3,9 \times 10^9/L$, linfócitos $1,7 \times 10^9/L$, plaquetas $298 \times 10^9/L$. VS 24 mm/h, PCR 4,8 mg/L, ambas inferiores a avaliação prévia. Ferritina 24 ng/mL, ferro sérico 48 µg/dL, saturação transferrina 14%, sem agravamento da ferropenia conhecida. Creatinina 0,78 mg/dL, eGFR 88 mL/min/1,73m², ureia 31 mg/dL, Na 139 mmol/L, K 4,1 mmol/L, Ca 9,3 mg/dL, fósforo 3,5 mg/dL. AST 21 U/L, ALT 24 U/L, GGT 19 U/L, FA 82 U/L, bilirrubina total 0,5 mg/dL, albumina 4,2 g/dL; sem citólise/hepatotoxicidade sob MTX. Glicemia 94 mg/dL. TSH 2,06 mUI/L, T4L 1,18 ng/dL. 25-OH vitamina D 34 ng/mL.

Rx mãos e punhos, controlo de Fevereiro/2026, com osteopenia periarticular discreta. Pequenas erosões marginais estáveis nas cabeças do 2.º e 3.º metacárpicos bilateralmente, sem novas erosões identificáveis. Interlinhas MCF e radiocárpicas globalmente preservadas, sem subluxações. Discreto aumento de partes moles periarticular junto às MCF, menos exuberante que no exame de 2025. Sem calcificações



Diário Clínico

Consulta Externa

lineares ou alterações compatíveis com condrocalcinose. Aspecto global de AR erosiva pouco agressiva, sem progressão radiográfica significativa.

Densitometria 17/02/2026: coluna lombar L1-L4 com DMO 0,812 g/cm², T-score -2,1; colo femoral esquerdo DMO 0,571 g/cm², T-score -2,5; fémur total esquerdo T-score -2,0. Comparativamente a DEXA prévia, redução da DMO no colo femoral, anteriormente em faixa osteopénica. Sem história de fractura de fragilidade. Achados compatíveis com osteoporose, provável contributo de corticoterapia cumulativa e doença inflamatória crónica.

Mantém MTX 15 mg/semana + AF, dada resposta clínica/laboratorial favorável e tolerância. Redução gradual prednisolona: 4 mg id durante 4 sem, depois 3 mg id durante 4 sem; se estabilidade clínica, prosseguir desmame progressivo 1 mg/mês até suspensão. Alertada para contactar se recrudescimento de rigidez >1h, artrite objectiva ou limitação funcional. Manter terapêutica anti-osteoporótica e aporte dietético de cálcio. Repetir hemograma, função renal, ionograma, perfil hepático, VS/PCR antes de próxima consulta. Reavaliação em 3 meses.

05-Abr-2026 Dr(a). Inês Valente (HUC-DERMATOLOGIA)

Mulher, 58 anos. Observada por mácula pigmentar isolada na face extensora do antebraço E, identificada há algumas semanas. Sem prurido, dor, hemorragia, ulceração ou crescimento rápido referido. Sem lesões semelhantes de aparecimento recente. AR sob MTX 15 mg/semana e prednisolona 5 mg/dia.

EO: TA 132/76 mmHg, FC 72 bpm, SatO₂ 98% AA, T 36,4°C. Fototipo II-III. Antebraços com lentigos solares dispersos, sem queratoses actínicas exuberantes. Lesão em causa macular, castanho-clara, ovalada, 5 x 4 mm, limites globalmente regulares, superfície lisa, sem descamação, crosta ou infiltração à palpação. Sem adenopatias epitrocleares palpáveis.

MCDT: dermatoscopia por luz polarizada evidencia padrão homogéneo castanho-claro, com rede pigmentar fina e regular na periferia. Áreas centrais discretamente estruturadas, sem assimetria cromática relevante. Ausência de véu azul-esbranquiçado, glóbulos irregulares, estrias/pseudópodes, áreas de regressão ou vasos atípicos. Sem critérios dermatoscópicos de melanoma ou outra lesão melanocítica suspeita. Aspecto global mais compatível com lentigo solar benigno.

Explicados sinais de alerta ABCDE e indicação para reobservação precoce se alteração dimensional, cromática, sintomática ou hemorragia. Fotoproteção regular SPF 50+ em áreas expostas. Vigilância clínica/dermatoscópica em 6 meses; fotografias clínicas de referência efectuadas.



Diário Clínico

Consulta Externa

22-Jun-2026 Dr(a). Rui Matos (HUC-NEUROLOGIA)

AP: epilepsia focal dx 2019, AR sob MTX/corticoterapia baixa dose, HTA, hipotireoidismo, DLP, anemia ferropénica crónica, osteoporose. Sem crises epiléticas há ~2 anos. Nega episódios de desconexão, automatismos, fenómenos sensitivos/motores paroxísticos, mioclonias, quedas ou traumatismos. Sem aura. Sem recurso a SU/internamentos por causa neurológica. Boa adesão a levetiracetam 500 mg 2id; sem efeitos adversos atribuíveis de forma clara. Sono preservado, sem privação recente. Nega etilismo.

Refere tontura breve, ocasional, sobretudo ao levantar-se rapidamente da cama/cadeira, sem vertigem rotatória sustentada, náusea, acufenos, diplopia, disartria ou défice focal acompanhante. Sem síncope, lipotímia com queda ou palpitações. Hipótese multifactorial discutida, no contexto de anti-hipertensores/diurético, polimedicação e eventual menor hidratação. Mantém perindopril/indapamida; sem alteração recente conhecida de posologia.

EO: consciente, colaborante, orientada x3. TA sentada 128/74 mmHg, ortostatismo 116/70 mmHg aos 3 min, FC 72 bpm regular, SpO2 98% AA, T 36,4°C. Sem nistagmo espontâneo, fala normofluente, pares cranianos sem alterações. Força 5/5 global, tônus e trofismo conservados; sem drift. ROT simétricos, cutâneo-plantar flexor bilateral. Sensibilidade superficial sem assimetrias. Provas dedo-nariz e calcanhar Joelho sem dismetria; marcha autónoma, tandem possível, Romberg negativo.

EEG de vigília/sonolência recente com ritmo posterior alfa 9-10 Hz, simétrico e reactivo à abertura ocular. Sem lentificação focal persistente. Hiperventilação sem indução de alterações paroxísticas. Estimulação luminosa intermitente sem resposta fotoparoxística. Não registadas descargas epileptiformes intercríticas nem crises electroclínicas durante o traçado. Mantém-se, contudo, contexto clínico compatível com epilepsia focal previamente diagnosticada, sem evidência electroencefalográfica actual de actividade irritativa.

Hemograma: Hb 11,4 g/dL, VGM 82 fL, leucócitos $6,8 \times 10^9/L$, plaquetas $286 \times 10^9/L$. Na 139 mmol/L, K 4,1 mmol/L, creatinina 0,78 mg/dL, eTFG 88 mL/min/1,73 m², AST 21 U/L, ALT 19 U/L. Sem alteração metabólica susceptível de reduzir limiar convulsivo.

Manter levetiracetam 500 mg 2id. Sem indicação para ajuste terapêutico ou repetição precoce de EEG. Reforçadas medidas posturais, hidratação e vigilância de TA domiciliária; eventual revisão anti-hipertensora com MGF se manutenção/agravamento das tonturas. Reavaliar Neurologia em 12 meses; antecipar por recorrência de crise, eventos de perda de consciência ou agravamento neurológico.



Diário Clínico

Consulta Externa

14-Ago-2026 Dr(a). Ricardo M. Figueiredo (HUC-MEDICINA_INTERNA)

58A, reavaliação global por polipatologia. AP: epilepsia focal dx 2019, sem crises há cerca de 2 anos; AR seropositiva de actividade clínica moderada, resposta parcial a MTX; HTA; hipotireoidismo substituído; DLP; anemia ferropénica crónica em contexto inflamatório; hérnia hiatal com esofagite ligeira; osteoporose por corticoterapia prolongada. Fácies discretamente cushingoide, sem outros estigmas de hipercortisolismo. Nódulo tiroideu 8 mm previamente caracterizado como benigno.

Sem intercorrências infecciosas, urgências ou internamentos desde última observação.

Sem crises parciais, ausências, fenómenos motores involuntários ou queixas cognitivas novas. Mantém rigidez matinal das pequenas articulações das mãos ~30-45 min, artralgias mecânicas/inflamatórias de baixa-moderada intensidade, sem tumefacção articular marcada ou limitação funcional major. Sem febre, perda ponderal, sudorese nocturna, adenopatias. Sem dispneia, dor torácica, palpitações, ortopneia, edemas periféricos ou síncope. Tontura postural esporádica, breve, sem queda. Sem queixas dispépticas relevantes sob IBP, sem disfagia, odinofagia, vómitos, melena ou rectorragias. Trânsito intestinal regular. Xerostomia habitual, sem candidíase oral ou lesões mucosas. Cefaleias tensionais ocasionais, sem sinais de alarme. ITU 08/2025, gastroenterite 01/2025 e lombalgia mecânica 03/2025 sem recorrência.

MH revista: levetiracetam 500 mg 2id; MTX 15 mg/semana + ácido fólico 5 mg/semana; prednisolona 5 mg id; perindopril 5 mg id + indapamida SR 1,5 mg id; levotiroxina 75 mcg id; rosuvastatina 10 mg id; sulfato ferroso 80 mg id; colecalciferol 25.000 UI/mês; alendronato 70 mg/semana; pantoprazol 40 mg id. Constava ainda omeprazol 20 mg id, sem indicação para duplicação de IBP. Boa adesão global, sem efeitos adversos claros. Alergia a penicilina com exantema generalizado; broncospasmo ligeiro prévio com contraste iodado.

EO: consciente, orientada, colaborante. Bom estado geral, normocorada, sem icterícia, apirética. TA 132/76 mmHg, FC 72 bpm regular, SpO2 98% AA, T 36,4°C, peso 67,8 kg, IMC 26,1 kg/m². AC: S1/S2 normofonéticas, sem sopros. AP: MV bilateralmente conservado, sem ruídos adventícios. Mãos com discreta dor à compressão MCF/PIF bilateral, sem sinovite exuberante, sem derrame; mobilidade preservada. Sem edemas maleolares. Neurológico sumário sem défice focal, marcha autónoma.

Analítica 08/2026: Hb 11,6 g/dL, Ht 35,8%, VGM 82 fL, HGM 26,5 pg, leucócitos $6,9 \times 10^9/L$, neutrófilos $4,2 \times 10^9/L$, plaquetas $286 \times 10^9/L$. Ferritina 24 ng/mL, ferro 48 µg/dL, transferrina 276 mg/dL, saturação transferrina 12%. VS 24 mm/1.^ªh, PCR 4,8 mg/L. Glicemia 92 mg/dL, ureia 34 mg/dL, creatinina 0,78 mg/dL, TFGe 88 mL/min/1,73m². Na 139 mmol/L, K 4,1 mmol/L, Cl 102 mmol/L, Ca 9,3 mg/dL, P 3,5 mg/dL, Mg 1,9 mg/dL. AST 21 U/L, ALT 19 U/L, GGT 24 U/L, FA 82 U/L, bilirrubina total 0,5 mg/dL, albumina 4,2 g/dL. Col-T 174 mg/dL, LDL 91 mg/dL, HDL 58 mg/dL, TG 126 mg/dL. TSH 1,84 mUI/L, T4L 1,18



Diário Clínico

Consulta Externa

ng/dL. Vitamina D 34 ng/mL. Sem citopenias ou citólise sob MTX; função renal e ionograma estáveis sob IEC/diurético.

Revista DMO 02/2026: coluna lombar L1-L4 T-score -2,6, colo femoral T-score -2,5, compatível com osteoporose, com agravamento face ao estudo anterior que documentava osteopenia femoral T-score -1,8. Sem história de fractura de fragilidade, dorsalgia aguda ou redução estatural referida. Mantém indicação para alendronato, vitamina D e medidas de prevenção de queda; reavaliar tolerância digestiva dada hérnia hiatal/esofagite. EDA 12/2025 com hérnia hiatal por deslizamento, esofagite distal ligeira, sem úlcera, estenose ou lesão suspeita; mantém indicação para seguimento em Gastreenterologia. Ecografia cervical prévia com nódulo tiroideu sólido-subcentimétrico de 8 mm, contornos regulares, sem microcalcificações ou adenopatias cervicais, padrão benigno; sem critério ecográfico actual para PAAF. Ecografia abdominal antiga com quisto renal simples cortical esquerdo 15 mm, paredes finas, sem septos ou dilatação pielocalicial; sem indicação para vigilância dirigida.

Manter levetiracetam, seguimento Neurologia, vigilância de recorrência crítica. Manter MTX/ácido fólico e prednisolona 5 mg, articulação com Reumatologia visando redução progressiva de corticóide se actividade o permitir; hemograma, transaminases, creatinina, VS/PCR seriados. Suspende omeprazol, manter apenas pantoprazol 40 mg id. Manter restante terapêutica. Reforçadas toma correcta de alendronato em jejum, água abundante e ortostatismo ≥ 30 min; suspender e contactar se disfagia/odinofagia. Vigilância anual TSH e ecografia tiroideia apenas se crescimento nodular/sintomas compressivos. Consulta MI 6 meses com analítica prévia; manter articulação Reumatologia, Neurologia, Gastreenterologia e MGF.